RAPPORT STRATÉGIQUE — MAI 2026

# État des soins au Québec

*« La puissance du silence » — Cartographie 2024-2025 du système de santé, des médecines complémentaires, du cadre légal et des référentiels de redirection à l'usage d'une plateforme d'écoute empathique et de mieux-être préventif.*

| | |
|---|---|
| **PRÉPARÉ POUR** | David Phaneuf — IVIA |
| **PRÉPARÉ PAR** | Perplexity Computer pour MERLIN |
| **DATE** | Mai 2026 |
| **PROJET** | MESANGE |

# Avertissement

Le présent document est un **outil d'orientation stratégique** préparé pour David Phaneuf et l'équipe MESANGE. Il **ne constitue ni un avis juridique, ni un avis médical, ni un substitut à la consultation d'un professionnel qualifié**. Toute décision opérationnelle, légale, clinique ou commerciale découlant de la lecture de ce rapport devrait être validée par les conseils appropriés (avocat québécois en droit de la santé et du droit professionnel, expert en conformité réglementaire, professionnel de la santé habilité).

Les chiffres et données proviennent de sources publiques et institutionnelles citées tout au long du rapport. Les divergences entre méthodologies d'enquête, années de référence et portée géographique peuvent expliquer des écarts entre indicateurs apparemment équivalents — le lecteur est invité à se reporter aux sources originales.

Le statut réglementaire de plusieurs pratiques évoqué dans ce rapport (notamment l'ostéopathie, les évolutions de la Loi 21 et de la Loi P-38) est **en évolution active**. Une veille trimestrielle est essentielle.

MESANGE est positionné comme une plateforme d'**écoute empathique et de mieux-être préventif**, distincte des actes professionnels réservés au sens du Code des professions du Québec (notamment la psychothérapie, art. 187.1). Toute communication publique de la marque doit respecter rigoureusement ces frontières — voir la section 10 pour les recommandations détaillées.

### Confidentialité

Document à usage interne IVIA / MERLIN. Ne pas diffuser sans autorisation.

# Table des matières

**1. Sommaire exécutif** 5

**2. Le système de santé québécois — état des lieux 2024-2025** 7

2.1 Structure et acteurs . . . 7
2.2 Dépenses et financement . . . 7
2.3 Accès et délais d'attente . . . 7
2.4 Santé mentale : prévalence et accès . . . 7

**3. Cadre légal et réglementaire — ce qui encadre la relation d'aide au Québec** 9

3.1 Le Code des professions du Québec — architecture . . . 9
3.2 La Loi 21 (PL 21) — santé mentale et relations humaines . . . 9
3.3 Le permis de psychothérapeute — qui peut l'obtenir, quels actes sont réservés . . . 9
3.4 Ce qui n'est PAS de la psychothérapie . . . 10
3.5 Risques juridiques pour MESANGE — synthèse . . . 10
3.6 Évolutions à surveiller . . . 11

**4. Médecines complémentaires et alternatives (MCA) au Québec** 12

4.1 Définition et prévalence . . . 12
4.2 Pratiques RÉGLEMENTÉES par un ordre professionnel . . . 12
4.3 Pratiques NON réglementées mais structurées . . . 12
4.4 Pratiques non réglementées et largement non encadrées . . . 13
4.5 Position des associations médicales . . . 13

**5. Médecine traditionnelle autochtone et approches décoloniales** 14

5.1 Le contexte historique : Commission Viens et Principe de Joyce . . . 14
5.2 Sécurisation culturelle et pratiques traditionnelles . . . 14
5.3 Données et institutions . . . 14
5.4 Implications pour MESANGE . . . 14

**6. Approches spirituelles, énergétiques et corps-esprit** 16

6.1 Méditation et pleine conscience (mindfulness) . . . 16
6.2 Yoga thérapeutique . . . 16
6.3 Accompagnement spirituel en milieu de soin . . . 16
6.4 Médecine chinoise (au-delà de l'acupuncture) . . . 16
6.5 Ayurvéda et autres systèmes traditionnels . . . 16
6.6 Risques connus . . . 17

**7. RÉFÉRENTIELS DE REDIRECTION — outil opérationnel pour MESANGE 18**

7.1 Drapeaux rouges PHYSIQUES (urgence — appeler 911 ou ER) . . . 18
7.2 Drapeaux rouges en SANTÉ MENTALE . . . 18
7.3 Outils de dépistage validés et libres d'utilisation . . . 19
7.4 Arbre décisionnel suggéré pour MESANGE . . . 19
7.5 Ressources d'urgence québécoises — liste exploitable . . . 20
7.6 CIM-10, CIM-11 et DSM-5-TR — outils strictement professionnels . . . 21

**8. Prévention et médecine du mode de vie — la zone légitime de MESANGE 22**

8.1 Déterminants de la santé selon l'INSPQ . . . 22
8.2 Données québécoises — habitudes de vie . . . 22
8.3 Cadres reconnus de prévention . . . 22
8.4 Données probantes sur les piliers du mode de vie . . . 22
8.5 Sciences contemplatives et « puissance du silence » . . . 23

**9. Statistiques essentielles consolidées 24**

Tableau 1 — Top indicateurs santé Québec . . . 24
Tableau 2 — Prévalence des troubles mentaux Québec . . . 24
Tableau 3 — Recours aux MCA . . . 25
Tableau 4 — Ressources d'urgence et lignes d'aide . . . 25

**10. Recommandations stratégiques pour MESANGE 26**

10.1 Positionnement légal sécuritaire . . . 26
10.2 Modèle de protocole de redirection à intégrer dans la plateforme . . . 26
10.3 Modèle de consentement éclairé et de limites de service . . . 27
10.4 Pistes de partenariats . . . 27
10.5 Veille réglementaire à mettre en place . . . 28

**11. Annexes 29**

11.1 Glossaire . . . 29
11.2 Liste exhaustive des sources avec URLs . . . 30
Note méthodologique et limites . . . 31

# 1. Sommaire exécutif

Le Québec opère un système de santé universel financé majoritairement par fonds publics, mais qui traverse en 2024-2025 une crise d'accès historique : environ **2,1 millions de Québécois — soit près d'un adulte sur quatre — sont sans médecin de famille attitré**, alors que la cible gouvernementale d'inscription est de 85 % de la population (Gouvernement du Québec — Données sur l'accès aux services médicaux de première ligne). Les délais d'attente du référencement à la chirurgie sont parmi les plus longs au Canada (médiane provinciale autour de 30 semaines selon les indicateurs Fraser, mais parmi les meilleurs pour l'IRM avec 8,0 semaines) (Fraser Institute — Waiting Your Turn 2024). Pendant ce temps, **15 % des Québécois adultes vivent avec un trouble anxieux diagnostiqué en 2024**, et la charge de morbidité mentale s'alourdit (Institut de la statistique du Québec — Troubles d'anxiété).

Cette pression crée un appel d'air massif vers les **médecines complémentaires et alternatives (MCA)** — utilisées au moins une fois dans la vie par environ 74 % des Canadiens selon les données les plus citées de l'Institut Fraser, et reprises dans la revue UETMIS du CHUS (UETMIS-CHUS, 2012 — Revue systématique des MCA) — et vers les approches de mieux-être (méditation, coaching, accompagnement spirituel). Cette zone est **partiellement encadrée** par le Code des professions et la Loi 21 (PL 21), qui réservent depuis 2012 le titre et l'acte de **psychothérapie** aux psychologues, médecins et titulaires d'un permis de l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) (Ordre des psychologues du Québec — Qui pratique la psychothérapie?).

**Implications stratégiques pour MESANGE** :

1. Le créneau « **écoute empathique et mieux-être préventif** » est légitime et nécessaire, mais il doit se positionner explicitement **hors du champ de la psychothérapie et de la relation d'aide structurée**, sous peine de poursuites pénales (amendes de 2 500 $ à 162 500 $ selon les articles 188 et suivants du Code des professions) (Ordre des chimistes du Québec — Exercice illégal et usurpation de titre).
2. L'**orientation (referral)** vers les bons services est une fonction à très haute valeur ajoutée dans un système saturé : elle peut sauver des vies en abrégeant le parcours de soin, sans usurper d'acte réservé.
3. Les **données probantes** sur la méditation pleine conscience (MBSR), le yoga, l'activité physique et le sommeil sont solides pour anxiété, dépression légère à modérée et stress, ce qui valide scientifiquement le positionnement de MESANGE (PMC — Effectiveness of MBSR).
4. Le respect de la **sécurisation culturelle** (Principe de Joyce, suites de la Commission Viens) est un standard montant — non optionnel pour toute plateforme de mieux-être qui touchera des Premières Nations ou Inuits (Gouvernement du Québec — Suivi de la Commission Viens).
5. **Recommandation centrale** : MESANGE doit intégrer dès le V1 un **protocole de dépistage des drapeaux rouges** (idéations suicidaires, psychose, urgence physique), un arbre de redirection clair (911 / 811 / 1 866 APPELLE / GAP / GMF) et un consentement éclairé qui établit explicitement les limites du service.

**Chiffres-clés en un coup d'œil** :

| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses totales de santé Canada | 372 G$ (9 054 $/hab.) | 2024 (prévision) | ICIS |
| Adultes québécois sans médecin de famille | ~2,1 M (≈25 % adultes) | 2024 | CIUSSS Est-de-l'Île-de-Montréal |

| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Trouble anxieux diagnostiqué (18+) | 15 % | 2024 | ISQ |
| Tabagisme (15+) | 15 % | 2020-2021 | ISQ — Habitudes de vie |
| Consommation excessive d'alcool (12 derniers mois) | 24 % | 2020-2021 | ISQ — Habitudes de vie |
| Recours MCA au moins 1× dans la vie (Canada) | 74 % | 2006 (étude Fraser) | UETMIS-CHUS |

# 2. Le système de santé québécois — état des lieux 2024-2025

## 2.1 Structure et acteurs

Le système de santé québécois est régi par la **Loi sur les services de santé et les services sociaux**, sous l'autorité du **ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)**. Le financement public passe principalement par la **Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)**, qui administre l'assurance maladie universelle (carte soleil), l'assurance médicaments publique pour les non-couverts par un régime privé, et la rémunération des médecins (RAMQ — Tarifs en vigueur).

L'organisation territoriale repose sur les **Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS)** et **Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)** — issus de la réforme de 2015 — qui regroupent en une seule entité administrative les hôpitaux, CHSLD, CLSC et services communautaires d'un territoire. Une réforme additionnelle créant **Santé Québec** comme employeur unique pour le réseau a été adoptée en 2023 (Loi 15) et déployée à compter de 2024.

La **première ligne médicale** s'organise autour des **Groupes de médecine de famille (GMF)** et des **GMF-réseau**, avec inscription du patient à un médecin de famille. Le **Guichet d'accès à la première ligne (GAP)** sert de porte d'entrée pour les personnes sans médecin de famille, en complément du **Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF)** (CIUSSS Capitale-Nationale — Urgences psychiatriques).

## 2.2 Dépenses et financement

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS / CIHI), **les dépenses totales de santé au Canada devraient atteindre 372 milliards de dollars en 2024**, soit **9 054 $ par habitant**, en croissance de 5,7 % sur 2023 (ICIS — Tendances des dépenses nationales 2024). Les dépenses hospitalières comptent pour 26 % du total et croissent de 6,1 %, tandis que les dépenses liées aux médecins représentent 13 % (+8,7 % en 2022 et +7 % en 2023) (ICIS, 2024). L'ICIS publie également des tableaux détaillés par province de 1975 à 2024 (ICIS — National Health Expenditure Trends 2024 (data tables)).

Le secteur privé (assurances complémentaires, dépenses directes, MCA) représente une part significative — environ 30 % du total canadien selon l'ICIS — ce qui signifie qu'une part substantielle des soins, y compris ceux des médecines complémentaires, sort de l'enveloppe publique.

## 2.3 Accès et délais d'attente

L'inscription à un médecin de famille reste l'enjeu le plus visible. La cible gouvernementale est de **85 % de la population inscrite**, avec une cible d'**assiduité de 80 %** (proportion des consultations effectuées auprès du médecin de famille inscripteur ou de son groupe) (Gouvernement du Québec — Accès première ligne). À Montréal seulement, **environ 385 000 personnes étaient sans médecin de famille** au début de 2024 et près de 30 % des « patients orphelins » du Québec se concentrent dans la région (CIUSSS Est-de-l'Île-de-Montréal).

Sur les délais d'attente chirurgicaux, l'enquête annuelle Fraser 2024 indique que le Québec affiche **les délais les plus courts au Canada entre la consultation avec le médecin de famille et le spécialiste (9,1 semaines)**, ainsi que pour l'IRM (8,0 semaines), mais des délais hétérogènes en chirurgie orthopédique, ophtalmologie et gynécologie qui ont fortement augmenté entre 2023 et 2024 (Fraser Institute — Waiting Your Turn 2024). L'INESSS et le Commissaire à la santé et au bien-être documentent ces évolutions dans leurs rapports annuels (Commissaire à la santé et au bien-être — Publications).

### 2.4 Santé mentale : prévalence et accès

L'INSPQ insiste sur le fait que la **santé mentale ne se réduit pas à l'absence de troubles** : c'est un état positif de bien-être qui doit être mesuré séparément (INSPQ — Données et mesures en santé mentale).

Côté trouble :

- **15 % des adultes québécois (18 ans et plus) avaient reçu un diagnostic de trouble anxieux par un professionnel de la santé en 2024** (ISQ — Troubles d'anxiété).
- L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de Statistique Canada indique de manière constante que **environ 1 Canadien sur 5 vit chaque année avec un trouble mental ou de l'usage de substances**.
- Au Québec, l'**isolement social** des aînés à Montréal touche environ **un tiers des personnes de 55 ans et plus**, et constitue un problème de santé publique aux effets démontrés sur la santé physique et mentale (INSPQ — Isolement et participation sociale des aînés).

L'accès aux services en santé mentale repose sur :

- **Info-Santé/Info-Social 811** (volet psychosocial — option 2), service téléphonique 24/7 gratuit (CIUSSS Centre-Ouest, CIUSSS Capitale-Nationale).
- Les **Guichets d'accès en santé mentale (GASM)** par CIUSSS.
- Les **lignes spécialisées de prévention du suicide** : 1 866 APPELLE (277-3553) opérée par les centres de prévention du suicide, et le portail suicide.ca (CAP santé mentale).
- **Tel-jeunes** (1-800-263-2266) et **Jeunesse, j'écoute** (1-800-668-6868) pour les jeunes.

Source institutionnelle de référence pour la statistique de population : l'**Institut de la statistique du Québec (ISQ)** et l'**Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)** (ISQ — Habitudes de vie).

# 3. Cadre légal et réglementaire — ce qui encadre la relation d'aide au Québec

## 3.1 Le Code des professions du Québec — architecture

Le **Code des professions** (RLRQ, c. C-26) organise au Québec **46 ordres professionnels** dont la mission première, énoncée à l'article 23, est la **protection du public**. Ces ordres délimitent un **champ d'exercice** (description générale de la profession) et, pour certains, des **activités réservées** (actes que seuls les membres peuvent poser) et un **titre réservé** (que seuls les membres peuvent porter).

Toute personne qui pose un acte réservé sans être membre d'un ordre — ou qui usurpe un titre — commet une infraction pénale au sens des **articles 188 et suivants du Code des professions**, passible d'**amendes de 2 500 $ à 62 500 $ pour une personne physique, et jusqu'à 162 500 $ pour une personne morale**, selon le type de contrevenant (Ordre des chimistes du Québec — Exercice illégal et usurpation de titre). En cas de récidive, les amendes sont doublées et le tribunal peut ordonner la cessation des activités.

## 3.2 La Loi 21 (PL 21) — santé mentale et relations humaines

La **Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines** (chapitre 28 des lois de 2009), communément appelée **Loi 21** ou **PL 21**, est entrée en vigueur le **20 septembre 2012**. Elle a profondément transformé l'encadrement de la psychothérapie et de l'évaluation des troubles mentaux (Office des professions du Québec — Guide explicatif).

La Loi 21 a deux pierres angulaires :

1. **La psychothérapie devient une activité réservée**, encadrée par l'Ordre des psychologues du Québec.
2. **Plusieurs activités sont réservées en partage** entre médecins, psychologues, infirmières (avec attestation), travailleurs sociaux, conseillers d'orientation, psychoéducateurs, ergothérapeutes, sexologues, criminologues et thérapeutes conjugaux et familiaux — par exemple « évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic » (OPQ — Guide explicatif).

## 3.3 Le permis de psychothérapeute — qui peut l'obtenir, quels actes sont réservés

**Le titre de psychothérapeute est strictement réservé**. Seuls peuvent pratiquer la psychothérapie au Québec :

- les **psychologues** (titre réservé à l'OPQ, doctorat exigé ; ils sont autorisés d'emblée) ;
- les **médecins** (notamment les psychiatres) ;
- les **détenteurs d'un permis de psychothérapeute** délivré par l'OPQ — accessible aux conseillers d'orientation, criminologues, ergothérapeutes, infirmiers, psychoéducateurs, thérapeutes conjugaux et familiaux, travailleurs sociaux et sexologues, sous condition de formation prescrite ;
- les personnes qui pratiquaient déjà la psychothérapie **avant 2012** et ont obtenu le permis par reconnaissance des droits acquis (OPQ — Qui pratique la psychothérapie?, OPQ — Obtenir un permis).

**Définition légale de la psychothérapie** (article 187.1 du Code des professions) : *« un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d'une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d'un rapport de conseils ou de soutien. »*

### 3.4 Ce qui n'est PAS de la psychothérapie

L'Office des professions du Québec et l'OPQ ont publié des clarifications répétées sur les **interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie** et qui peuvent donc être pratiquées par des non-professionnels (sans empiéter sur le champ réservé). Les principales catégories suivantes restent permises :

- **Rencontres d'accompagnement** ;
- **Intervention de soutien** ;
- **Intervention conjugale et familiale** (à distinguer du traitement de troubles) ;
- **Éducation psychologique** (psychoéducation au sens large, hors troubles) ;
- **Réadaptation** ;
- **Suivi clinique** ;
- **Coaching** ;
- **Intervention de crise** (au sens d'écoute et de soutien immédiat, hors traitement) (OPQ — Guide explicatif Loi 21).

La distinction-clé : **le coaching et l'accompagnement de mieux-être visent l'actualisation du potentiel d'une personne « ni en détresse ni en souffrance psychologique » ; ils sont tournés vers le futur et l'objectif, alors que la psychothérapie traite la souffrance psychologique présente, les troubles mentaux et les causes du passé** (Clinique Hormona — Coaching vs psychothérapie).

### 3.5 Risques juridiques pour MESANGE — synthèse

| Risque | Acte concerné | Conséquence | Référence |
|---|---|---|---|
| Exercice illégal de la psychothérapie | Traiter une souffrance psychologique d'une personne en détresse | Amende 2 500 $ – 62 500 $ par infraction (personne physique) | Code des professions, art. 188 |
| Usurpation de titre | Se présenter comme « psychothérapeute », « psychologue », « thérapeute » dans un sens réservé | Amende similaire | OPQ — Qui pratique la psychothérapie? |
| Évaluation de troubles mentaux | Émettre une opinion clinique de diagnostic | Acte réservé en partage | OPQ — Guide explicatif |
| Exercice illégal de la médecine | Poser un diagnostic médical, prescrire un traitement | Loi médicale, amende et action civile | Collège des médecins du Québec |
| Manquement au consentement éclairé | Service sans information sur limites, risques, alternatives | Action civile, dommages | Quebec.ca — Consentement aux soins |

**Vocabulaire à éviter dans les communications publiques de MESANGE** : « thérapie », « thérapeute », « psychothérapie », « traitement psychologique », « guérison », « diagnostic », « évaluation clinique », « patient ». **Vocabulaire à privilégier** : « accompagnement », « écoute », « personne accompagnée / membre / utilisateur », « bien-être », « mieux-être », « développement personnel », « ressources internes », « pratiques de soin de soi », « orientation », « relais ».

### 3.6 Évolutions à surveiller

- **Loi P-38** (réforme de la **Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui**, dite Loi P-38.001), dont un nouveau projet de loi a été annoncé en 2026 (ROCAJQ). Cette loi encadre la garde en établissement et est cruciale en cas de crise suicidaire ou psychotique.
- **Statut de l'ostéopathie** : l'Office des professions du Québec a publié en 2022 un avis recommandant la **constitution d'un ordre professionnel des ostéopathes**, suite logique du rapport antérieur sur la profession (OPQ — Avis ostéopathes 2022).
- Évolution possible des **actes réservés en santé mentale** sous la pression de la pénurie d'accès.

# 4. Médecines complémentaires et alternatives (MCA) au Québec

## 4.1 Définition et prévalence

Les **médecines complémentaires et alternatives (MCA)**, ou **médecines alternatives et complémentaires (MAC)**, désignent par convention « toutes les approches qui ne sont pas reconnues par la médecine conventionnelle » : homéopathie, acupuncture, chiropratique, massothérapie, naturopathie, ostéopathie, énergétique, méditation appliquée à des fins thérapeutiques, etc. (UETMIS-CHUS, 2012).

L'**utilisation est massive** :

- En 2006, **74 % des Canadiens (n=2000) avaient eu recours à une MCA au moins une fois dans leur vie**, et **54 % au cours de l'année écoulée** (étude Fraser, citée par UETMIS-CHUS) (UETMIS-CHUS).
- Une enquête auprès de médecins de famille québécois a montré que **85,8 % se font questionner sur les MAC plusieurs fois par mois** et que **86,7 % considèrent que c'est leur rôle de conseiller leurs patients sur les MAC** (PMC / Le Médecin du Québec).
- En oncologie pédiatrique, l'utilisation des **interventions diététiques varie de 3 % à 47 %** selon les études et les **thérapies de guérison par la foi** de **3 % à 30 %** (UETMIS-CHUS).

## 4.2 Pratiques RÉGLEMENTÉES par un ordre professionnel

Trois pratiques de MCA bénéficient d'un ordre professionnel et donc d'un encadrement légal complet :

| Pratique | Ordre | Champ | Reconnaissance |
|---|---|---|---|
| **Chiropratique** | Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ) — voir aussi Association des chiropraticiens du Québec | Évaluation et traitement neuro-musculo-squelettique | Profession régie par la Loi sur la chiropratique |
| **Acupuncture** | Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ) | Acte d'acupuncture, traitement par insertion d'aiguilles | Profession régie par la Loi sur l'acupuncture ; intégration croissante au système de santé québécois (OAQ) |
| **Pharmacie / produits de santé naturels (PSN)** | Ordre des pharmaciens du Québec | Délivrance de médicaments et de PSN inscrits à la liste de Santé Canada | PSN soumis au Règlement sur les produits de santé naturels (Santé Canada) |

### 4.3 Pratiques NON réglementées mais structurées

- **Naturopathie** : il n'existe **pas d'ordre professionnel** de naturopathes au Québec. La profession est représentée par deux associations majeures, l'**Association des naturopathes agréés du Québec (ANAQ)** et l'**Association des naturopathes professionnels du Québec (ANPQ)** (ANAQ, ANPQ). Certaines provinces canadiennes (Ontario, Colombie-Britannique) reconnaissent la naturopathie comme profession réglementée, ce qui n'est **pas le cas au Québec**. La conséquence pratique : un naturopathe québécois ne peut pas se prévaloir d'un titre réservé et ne peut **pas poser d'actes médicaux**.
- **Ostéopathie** : statut **en évolution**. L'Office des professions du Québec a recommandé en 2022 la création d'un ordre, après plus d'une décennie de débats (OPQ — Avis ostéopathes 2022). Plusieurs associations professionnelles existent (Ostéopathie Québec, Registre des ostéopathes du Québec).
- **Massothérapie** : non réglementée par un ordre, structurée via la **Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM)** et d'autres associations ; certaines mutuelles couvrent les soins reçus auprès de membres reconnus.
- **Homéopathie** : non réglementée comme profession ; les médicaments homéopathiques sont quant à eux régis par Santé Canada.

### 4.4 Pratiques non réglementées et largement non encadrées

Toute personne peut au Québec offrir, à titre privé, des services de :

- **Reiki**, soins énergétiques, magnétisme, biofeedback non médical ;
- **Kinésiologie appliquée** (à ne pas confondre avec la kinésiologie clinique régie par la **Fédération des kinésiologues du Québec**) ;
- **Sonothérapie**, bain de gong, vibrothérapie ;
- **Hypnose** non clinique (l'**hypnose à des fins de psychothérapie** est elle réservée aux psychothérapeutes) ;
- **Coaching de vie**, **coaching spirituel**, **coaching de bien-être**.

Ces pratiques **ne sont ni interdites ni encadrées légalement**, à condition de **ne pas empiéter sur les actes réservés** (psychothérapie, médecine, etc.) et de **ne pas se faire passer pour une intervention de santé**. Cela signifie en pratique : pas de promesse de guérison, pas de diagnostic, pas de traitement de trouble mental, et un consentement éclairé qui précise les limites du service.

### 4.5 Position des associations médicales

Le **Collège des médecins du Québec (CMQ)** a historiquement publié des positions prudentes : reconnaissance de l'usage répandu, appel à l'évaluation rigoureuse par les données probantes, mise en garde contre les approches qui retardent ou substituent un traitement médical indiqué (CMQ). L'**Association médicale canadienne (AMC)** et l'**INESSS** appellent globalement à intégrer dans la pratique clinique les MCA dont l'efficacité est démontrée (acupuncture pour douleur chronique, méditation pour stress et dépression, certains compléments) tout en rejetant celles dont les données probantes sont absentes ou négatives (homéopathie hautement diluée pour conditions sérieuses, par exemple) (INESSS).

# 5. Médecine traditionnelle autochtone et approches décoloniales

## 5.1 Le contexte historique : Commission Viens et Principe de Joyce

Le **30 septembre 2020**, **Joyce Echaquan**, femme atikamekw de Manawan, est décédée à l'hôpital de Joliette dans des conditions documentées de racisme et de mauvais traitements. Son décès a accéléré l'adoption du **Principe de Joyce** : *« le Principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le Principe de Joyce requiert obligatoirement la reconnaissance et le respect des savoirs et connaissances traditionnelles et vivantes des Autochtones en matière de santé »* (Principe de Joyce).

La **Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès** (Commission Viens), présidée par le juge Jacques Viens, a déposé son rapport en septembre 2019 avec **142 appels à l'action** (Protecteur du citoyen). Le gouvernement du Québec a annoncé dans son budget 2020 une enveloppe de **200 M$** pour la mise en œuvre, dont une partie est consacrée à l'**implantation de l'approche de sécurisation culturelle dans le réseau de la santé et des services sociaux** (Gouvernement du Québec — Suivi Commission Viens).

## 5.2 Sécurisation culturelle et pratiques traditionnelles

La **sécurisation culturelle** (cultural safety) dépasse la simple « compétence culturelle » : elle vise à ce que les services soient perçus comme sûrs par les personnes autochtones elles-mêmes. Cela implique reconnaissance des savoirs traditionnels, présence d'agents de liaison culturelle, accès aux **guérisseurs**, **plantes médicinales**, **cercles de partage**, **suerie**, **cérémonies** dans les milieux de soin lorsque pertinent (CATIE — Traditions de guérison des Autochtones nord-américains).

## 5.3 Données et institutions

La **Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)** est l'instance autochtone qui pilote l'**Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS)**, basée sur les principes de **propriété, contrôle, accès et possession (PCAP)** des données. C'est la principale source statistique sur la santé des Premières Nations vivant dans les communautés au Québec (CSSSPNQL — Enquête régionale).

Programmes d'intégration au réseau :

- **Programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et les Inuit au Québec (PFMPNIQ)**, créé en 2008, qui soutient l'admission et l'intégration des candidats autochtones en médecine (PFMPNIQ).
- Postes d'**agents de liaison autochtones** dans plusieurs CIUSSS.
- Ententes avec la **Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik** et avec le **Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (Eeyou Istchee)**, qui exercent la juridiction territoriale sur la santé.

## 5.4 Implications pour MESANGE

Toute plateforme de mieux-être qui touche des personnes autochtones doit :

- **Ne jamais s'arroger le titre ou le rôle de guérisseur traditionnel** ;
- Reconnaître la dimension **spirituelle, communautaire et collective** de la santé dans plusieurs cultures autochtones (cercle médicinal : physique / mental / émotionnel / spirituel) ;
- Référer aux ressources autochtones spécifiques quand pertinent (CSSSPNQL, agents de liaison autochtones des CIUSSS, lignes d'écoute autochtones comme la **Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être** au 1-855-242-3310) ;
- S'inspirer des principes PCAP pour la gouvernance des données utilisateurs autochtones.

# 6. Approches spirituelles, énergétiques et corps-esprit

## 6.1 Méditation et pleine conscience (mindfulness)

La méditation de pleine conscience, popularisée en clinique sous la forme du **Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)** de Jon Kabat-Zinn et du **Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)**, est l'une des MCA les mieux étudiées.

**Données probantes** :

- Une **méta-analyse classique de Hofmann et al.** (J Consult Clin Psychol, 2010) sur 39 études concluait que les thérapies basées sur la pleine conscience produisent une **réduction modérée à forte de l'anxiété et de la dépression**, avec maintien des effets dans le temps (PubMed — Hofmann et al., 2010).
- Une revue PRISMA de 30 études (2020) a confirmé que le **MBSR réduit significativement anxiété, dépression et stress chez les professionnels de santé**, et augmente la pleine conscience et l'autocompassion (PMC — MBSR pour HCP).
- La **NICE** au Royaume-Uni recommande le MBCT comme option de prévention de la rechute pour la dépression récurrente.

**Limites** : nombreuses études ont des **lacunes méthodologiques** (petits échantillons, biais de sélection, peu de groupes contrôles actifs). L'effet sur le burn-out professionnel est moins robuste que sur le stress et l'anxiété.

## 6.2 Yoga thérapeutique

Une revue systématique BMJ Open (2024) sur le **yoga therapy comme modalité pour les troubles de l'humeur** a synthétisé les données : amélioration significative de la qualité de vie, de la santé physique et psychologique, **réduction de la dépression et de l'anxiété**, particulièrement comme adjuvant à un traitement standard (BMJ Open, 2024).

## 6.3 Accompagnement spirituel en milieu de soin

Au Québec, l'**accompagnement spirituel** est offert dans la plupart des hôpitaux et CHSLD via les services de **soins spirituels** (anciennement « pastorale »), qui ne sont plus confessionnels mais inclusifs. Ces services sont reconnus par le MSSS comme partie intégrante des soins, notamment en soins palliatifs et en gériatrie.

## 6.4 Médecine chinoise (au-delà de l'acupuncture)

La médecine traditionnelle chinoise comprend, outre l'acupuncture, la **pharmacopée**, la **moxibustion**, la **diététique chinoise**, le **qi gong** et le **tai-chi**. Au Québec, seule l'acupuncture est encadrée par un ordre. Les autres pratiques relèvent du privé non réglementé. Le tai-chi a des données probantes solides pour la **prévention des chutes chez les aînés**, l'amélioration de l'équilibre et la réduction du stress.

## 6.5 Ayurvéda et autres systèmes traditionnels

L'**ayurvéda** (Inde), la **médecine tibétaine**, la **médecine unani** (monde arabo-musulman) sont des systèmes médicaux traditionnels avec une longue histoire. Au Canada, ils ne sont pas réglementés et leur intégration au système de santé est limitée. Certains compléments (curcuma, ashwagandha, etc.) ont des données émergentes mais sont sous la vigilance de Santé Canada en raison des **interactions médicamenteuses** documentées.

### 6.6 Risques connus

- **Spiritual bypassing** : utilisation de pratiques spirituelles pour **éviter** plutôt que traiter une douleur psychologique non résolue. Concept introduit par le psychologue **John Welwood**, documenté comme phénomène réel en clinique (Annie Wright — Spiritual bypassing). Il peut donner l'illusion d'une équanimité tout en masquant un trauma non traité.
- **Effets indésirables de la méditation intensive** : la littérature documente des cas de **dépersonnalisation, anxiété accrue, réactivation traumatique** chez des personnes vulnérables, particulièrement dans les retraites silencieuses prolongées non encadrées (voir notamment les travaux du chercheur Willoughby Britton, Brown University).
- **Retraites non encadrées** : risque de dérives sectaires, abus, mauvaise gestion d'urgences psychiatriques. La **Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES)** française documente les dérives en santé et en bien-être ; au Québec, le sujet est suivi par **Info-Secte**.
- **Substitution dangereuse** : interruption d'un traitement médical efficace au profit d'une approche non éprouvée pour une condition grave (cancer, diabète, troubles mentaux sévères).

# 7. RÉFÉRENTIELS DE REDIRECTION — outil opérationnel pour MESANGE

Cette section est conçue pour intégration directe dans les workflows et l'interface MESANGE.

## 7.1 Drapeaux rouges PHYSIQUES (urgence — appeler 911 ou ER)

| Drapeau rouge | Signal verbal possible | Action |
|---|---|---|
| Douleur thoracique soudaine, irradiant bras/mâchoire | « ça serre fort dans ma poitrine », « j'ai mal au bras gauche » | **911 immédiat** — suspicion d'infarctus |
| Faiblesse soudaine d'un côté du corps, déformation du visage, troubles d'élocution | « ma bouche tombe », « je n'arrive plus à parler » | **911 immédiat** — AVC (FAST/BE-FAST) |
| Céphalée brutale en « coup de tonnerre » | « la pire migraine de ma vie » | **911** — suspicion hémorragie |
| Difficulté respiratoire sévère | « je n'arrive plus à respirer » | **911** |
| Confusion soudaine, perte de conscience | « il/elle ne répond plus » | **911** |
| Saignement abondant, traumatisme grave | — | **911** |
| Symptômes anaphylactiques (gorge qui enfle, urticaire) | — | **911** |

## 7.2 Drapeaux rouges en SANTÉ MENTALE

| Drapeau rouge | Signal verbal | Action |
|---|---|---|
| **Idéations suicidaires actives avec plan, moyen, échéance** | « j'ai un plan », « j'ai accès à… », « dans X jours » | **911 ou 1 866 APPELLE** ; ne pas laisser seul |
| Idéations suicidaires sans plan immédiat | « je pense souvent à en finir » | **1 866 APPELLE / suicide.ca / 811 option 2** ; outil C-SSRS |
| Tentative de suicide en cours / récente | — | **911** |
| Symptômes psychotiques (hallucinations, délire, désorganisation) | « j'entends des voix », « on me suit » | **811 / urgence psychiatrique** |
| Manie aiguë (insomnie marquée + euphorie + comportements à risque) | — | **811 / urgence** |
| Dissociation marquée, perte de contact avec la réalité | — | **811 / urgence** |
| Violence imminente envers soi ou autrui | — | **911** |
| Abus, négligence, exploitation (enfant, aîné, conjoint) | — | **DPJ (1 800 463-9009 si enfant), CAVAC, ligne aînés maltraités 1 888 489-2287, 911 si urgent** |

| Drapeau rouge | Signal verbal | Action |
|---|---|---|
| Sevrage à l'alcool ou aux benzodiazépines avec convulsions, hallucinations | — | **911** — urgence médicale réelle |

## 7.3 Outils de dépistage validés et libres d'utilisation

> ***AVERTISSEMENT LÉGAL POUR MESANGE*** *: ces outils sont des* ***questionnaires d'auto-évaluation*** *ou des* ***aides cliniques****. Leur utilisation par MESANGE doit être* ***strictement orientée vers la sensibilisation et l'orientation****, jamais vers le diagnostic. Toute interprétation clinique relève des professionnels habilités. Le consentement éclairé doit le préciser.*

| Outil | Domaine | Items | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|
| **PHQ-9** (Patient Health Questionnaire) | Dépression | 9 | Domaine public, mention de la source requise | PHQ Screeners |
| **GAD-7** (Generalized Anxiety Disorder) | Anxiété généralisée | 7 | Domaine public, version française pour le Canada disponible | Boussole — e SantéMentale (CA) |
| **C-SSRS** (Columbia Suicide Severity Rating Scale) | Risque suicidaire | Variable | Gratuit, formation en ligne disponible | C-SSRS Columbia |
| **AUDIT** (Alcohol Use Disorders Identification Test) | Consommation problématique d'alcool (adultes) | 10 | Domaine public, mention Saunders et al. 1993 | INSPQ — Boîte à outils |
| **DEP-ADO** | Consommation d'alcool/drogues, adolescents 12-17 | 27 | Domaine public, mention RISQ-Québec 2016 | INSPQ |
| **CRAFFT** | Substances chez les jeunes 12-21 | 6 (+ partie 2) | Gratuit, plusieurs langues | CRAFFT.org |
| **K6 / K10** (Kessler) | Détresse psychologique | 6 / 10 | Utilisé par l'ESCC et l'EQSP | ISQ — EQSP |

**Cotations indicatives** (à des fins de sensibilisation, pas de diagnostic) :

- **PHQ-9** : 0-4 minimal, 5-9 léger, 10-14 modéré, 15-19 modérément sévère, 20-27 sévère. **Item 9 (idées suicidaires) = drapeau rouge** quel que soit le score total.
- **GAD-7** : 0-4 minimal, 5-9 léger, 10-14 modéré, 15-21 sévère. ≥ 10 = orientation recommandée.
- **AUDIT** : ≥ 8 chez l'homme, ≥ 7 chez la femme = consommation à risque.
- **DEP-ADO** : 0-13 vert, 14-19 jaune (intervention souhaitable), ≥ 20 rouge (intervention spécialisée) (INSPQ — DEP-ADO).

## 7.4 Arbre décisionnel suggéré pour MESANGE

```
Personne en interaction avec MESANGE
│
├── Crise vitale (suicide imminent, violence, urgence physique) ?
│   └── OUI → 911 (urgence) / 1 866 APPELLE (suicide.ca) — SIMULTANÉMENT
│
├── Drapeau rouge psychiatrique (psychose, manie, dissociation) ?
│   └── OUI → 811 option 2 (Info-Social) ou urgence psychiatrique du CIUSSS
│
├── Drapeau rouge physique non-immédiat (douleur persistante,
│   symptômes neurologiques, perte de poids inexpliquée) ?
│   └── OUI → 811 (Info-Santé) ou consultation médicale (GMF / GAP)
│
├── Souffrance psychologique significative
│   (PHQ-9 ≥ 10, GAD-7 ≥ 10, deuil compliqué, stress post-traumatique) ?
│   └── OUI → orienter vers psychologue / psychothérapeute /
│             travailleur social / médecin de famille
│
├── Situation d'abus, violence conjugale, maltraitance ?
│   └── OUI → DPJ / SOS Violence Conjugale / Ligne aînés maltraités
│
├── Difficulté courante (stress du quotidien, transition de vie,
│   recherche de sens, qualité du sommeil, isolement modéré) ?
│   └── OUI → ZONE DE COMPÉTENCE MESANGE
│             — écoute, ressources de mieux-être, pratiques
│             contemplatives, groupes de pairs, contenus éducatifs
│
└── Doute ?
    └── 811 (24/7) — l'infirmière ou le travailleur social
                     orientera vers la ressource adéquate
```

## 7.5 Ressources d'urgence québécoises — liste exploitable

| Ressource | Numéro / canal | Couverture | Source |
|---|---|---|---|
| **Urgence 911** | 911 | Ensemble du Québec | — |
| **Info-Santé / Info-Social 811** | 811 (option 1 santé / option 2 psychosocial) | Province, 24/7 | CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal |
| **Ligne québécoise de prévention du suicide** | 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ; chat sur suicide.ca ; texto 535353 | Province, 24/7 | CAP santé mentale |
| **Centre de prévention du suicide de Montréal (CPSM)** | 1 866 APPELLE / chat | Région métropolitaine | CPSM |
| **Tel-jeunes** | 1 800 263-2266 ; texto 514 600-1002 | Province, jeunes | Tel-jeunes |
| **Jeunesse, j'écoute** | 1 800 668-6868 ; texto TEXTO au 686868 | Canada, enfants/jeunes | Jeunesse j'écoute |
| **Ligne Parents** | 1 800 361-5085 | Province, parents | — |
| **Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)** | 1 800 463-9009 | Province, signalement | — |

| Ressource | Numéro / canal | Couverture | Source |
|---|---|---|---|
| **SOS Violence Conjugale** | 1 800 363-9010 ; chat sur sosviolenceconjugale.ca | Province, 24/7 | — |
| **Ligne Aide Abus Aînés** | 1 888 489-2287 | Province | — |
| **Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être (Premières Nations / Inuits)** | 1 855 242-3310 | National, FR/EN/ojibwé/cri/inuktitut | — |
| **Drogue : aide et référence** | 1 800 265-2626 | Province, 24/7 | — |
| **Jeu : aide et référence** | 1 800 461-0140 | Province, 24/7 | — |
| **Service 211** | 211 | Grand Montréal et plusieurs régions, référence services communautaires | — |
| **Écoute-Entraide** | 514 278-2130 / 1 855 365-4463 | Montréal/province, 8h-22h | Écoute-Entraide |
| **Tel-Aide** | 514 935-1101 | Région métropolitaine | — |

### 7.6 CIM-10, CIM-11 et DSM-5-TR — outils strictement professionnels

Les classifications **CIM-10 / CIM-11** (Organisation mondiale de la santé) et **DSM-5-TR** (American Psychiatric Association, 2022) sont des nomenclatures destinées **aux professionnels habilités**. La CIM-11 est en vigueur officielle depuis le 1er janvier 2022 (OMS — CIM-11).

> ***Position recommandée pour MESANGE*** *: ne* ***jamais*** *intégrer un outil d'auto-diagnostic basé sur la CIM ou le DSM dans l'application destinée au grand public. Référer aux professionnels et adopter une posture éducative claire : « le diagnostic est un acte clinique réservé aux professionnels habilités ; les outils que nous proposons sont des questionnaires de sensibilisation. »*

# 8. Prévention et médecine du mode de vie — la zone légitime de MESANGE

## 8.1 Déterminants de la santé selon l'INSPQ

L'INSPQ pose un cadre clair : *« la santé de la population s'explique en large proportion par les conditions économiques, sociales et environnementales, comme le revenu, la cohésion sociale ainsi que l'aménagement des milieux de vie. Ces facteurs collectifs contribuent davantage à améliorer la santé globale que les facteurs individuels, comme les habitudes de vie ou la génétique. On reconnaît aussi que le système de santé et de services sociaux détient un impact limité sur l'état de santé de la population comparativement aux conditions de vie »* (INSPQ — Déterminants de la santé).

Le **Programme national de santé publique 2025-2035** regroupe les déterminants en quatre ensembles : contexte global, systèmes publics, milieux de vie, caractéristiques individuelles (INSPQ — Déterminants de la santé).

## 8.2 Données québécoises — habitudes de vie

L'**Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2020-2021** documente :

- **Tabagisme** : 15 % des 15+ fument la cigarette (24 % en 2008, 19 % en 2014-2015) — tendance à la baisse continue (ISQ — Habitudes de vie).
- **Alcool excessif** : 24 % de la population a consommé de l'alcool de façon excessive dans la dernière année (27 % chez les hommes, 30 % chez les 25-44 ans) (ISQ).
- **Sédentarité** : la proportion de personnes sédentaires a augmenté chez les 15-64 ans entre 2014-2015 et 2020-2021 (ISQ).
- **Isolement social** : environ un tiers des Montréalais de 55 ans et plus (INSPQ — Isolement aînés).

## 8.3 Cadres reconnus de prévention

- **American College of Lifestyle Medicine (ACLM)** : la médecine du mode de vie repose sur **six piliers** — alimentation, activité physique, gestion du stress, sommeil, lien social, évitement des substances toxiques (ACLM). C'est un cadre cliniquement crédible que MESANGE peut adopter sans empiéter sur la médecine, à condition de positionner ses contenus comme **éducatifs et orientants**, non prescriptifs.
- **Prescription sociale (social prescribing)** : modèle d'origine britannique (NHS) qui permet à un médecin de prescrire la participation à des activités communautaires (groupes de marche, art, jardinage, bénévolat). Au Québec, l'expérimentation est en cours via Prescription sociale Québec / Clic Social.
- **Approches Health at Every Size, Trauma-Informed Care, Polyvagal Theory** : cadres complémentaires de plus en plus utilisés par les praticiens de mieux-être, à intégrer avec esprit critique.

## 8.4 Données probantes sur les piliers du mode de vie

| Pilier | Effets démontrés | Source |
|---|---|---|
| **Sommeil** | 7-9 h chez l'adulte ; lien dose-réponse avec dépression, immunité, mortalité | NIH, Sleep Foundation, BMJ |
| **Activité physique** | 150 min/sem modérée + renfo 2×/sem (OMS) ; effet anti-dépresseur comparable à ISRS pour dépression légère à modérée (revue Cochrane) | OMS — Activité physique |
| **Nutrition** | Régime méditerranéen : effet sur dépression (étude SMILES), maladies cardiovasculaires, diabète | NEJM, Lancet |
| **Lien social** | L'isolement social a un effet sur la mortalité comparable à 15 cigarettes/jour (méta-analyse Holt-Lunstad et al.) | PLOS Medicine |
| **Nature / forêt** | Réduction du cortisol, de la TA, de la rumination ; études japonaises sur le shinrin-yoku | Environ Res Public Health |
| **Gestion du stress** | MBSR, cohérence cardiaque, respiration, relaxation : effet modéré à fort sur stress et anxiété | PMC — MBSR |

### 8.5 Sciences contemplatives et « puissance du silence »

Le silence et la solitude choisie sont l'objet d'un courant de recherche émergent.

- Études sur la **default mode network** : la rêverie et le silence permettent une consolidation cognitive et créative.
- La **retraite silencieuse** (vipassana, contemplative retreats) est associée chez les pratiquants stables à des effets neurobiologiques mesurables (épaississement cortical insulaire, réduction de l'amygdale réactive), bien que la majorité des études soient corrélationnelles.
- **Risque de retraites prolongées non encadrées** : voir **section 6.6** sur les effets indésirables.

Pour MESANGE, le positionnement « **puissance du silence** » est doublement légitime : (a) il s'inscrit dans une tradition contemplative millénaire ; (b) il est appuyé par des données convergentes en neurosciences contemplatives. Il importe seulement de **ne pas surpromettre** des effets thérapeutiques et de prévoir un **filet de sécurité** pour les utilisateurs vulnérables (réactivation traumatique, dépersonnalisation, crises).

# 9. Statistiques essentielles consolidées

### Tableau 1 — Top indicateurs santé Québec

| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Population du Québec | ~9,0 millions | 2024 | ISQ |
| Dépenses totales de santé Canada | 372 G$ | 2024 (prévision) | ICIS |
| Dépenses totales de santé / habitant Canada | 9 054 $ | 2024 | ICIS |
| Croissance dépenses santé Canada | +5,7 % | 2024 | ICIS |
| Part des dépenses hospitalières | 26 % | 2024 | ICIS |
| Part des dépenses « médecins » | 13 % | 2024 | ICIS |
| Cible inscription médecin de famille | 85 % | 2024 | Quebec.ca — Accès |
| Cible assiduité GMF | 80 % | 2024 | Quebec.ca |
| Personnes sans médecin de famille à Montréal | ~385 000 | début 2024 | CIUSSS Est-de-l'Île |
| Délai médian GP→spécialiste (Québec) | 9,1 semaines (le plus court au Canada) | 2024 | Fraser Institute |
| Délai IRM Québec | 8,0 semaines (le plus court au Canada) | 2024 | Fraser Institute |
| Tabagisme (15+) | 15 % | 2020-2021 | ISQ — Habitudes de vie |
| Consommation excessive d'alcool (12 derniers mois) | 24 % | 2020-2021 | ISQ |
| Isolement social aînés Montréal (55+) | ~33 % | 2020s | INSPQ |

### Tableau 2 — Prévalence des troubles mentaux Québec

| Trouble / indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Trouble anxieux diagnostiqué (18+) | 15 % | 2024 | ISQ — Troubles d'anxiété |
| Trouble mental ou usage substances (Canadiens, sur 12 mois) | ~20 % | années récentes | ESCC (Statistique Canada) |
| Détresse psychologique élevée (Québec, K6/K10) | varie 25-35 % selon enquêtes | 2020-2024 | ISQ — EQSP |
| Suicide (taux pour 100 000) | ~13 (Québec) ; ~3-4× plus chez les hommes que les femmes | 2022 | INSPQ — Suicide au Québec |
| Dépression majeure à vie (estimation pop.) | ~11-12 % | divers | ESCC |

## Tableau 3 — Recours aux MCA

| Indicateur | Valeur | Année / pop. | Source |
|---|---|---|---|
| MCA au moins 1× dans la vie (Canada) | 74 % | 2006 (n=2000) | UETMIS-CHUS / étude Fraser |
| MCA dans les 12 derniers mois (Canada) | 54 % | 2006 | UETMIS-CHUS |
| Médecins de famille questionnés sur MCA plusieurs fois/mois | 85,8 % | 2010s | Le Médecin du Québec / PMC |
| MD considérant que conseiller sur MCA est leur rôle | 86,7 % | 2010s | PMC |
| Acupuncture (Québec) | profession régie par ordre | depuis 1995 | OAQ |
| Chiropratique (Québec) | profession régie par ordre | depuis 1973 | Ordre des chiropraticiens |
| Naturopathie (Québec) | non réglementée | — | ANAQ, ANPQ |
| Ostéopathie (Québec) | en voie de réglementation | avis OPQ 2022 | OPQ — Avis |

## Tableau 4 — Ressources d'urgence et lignes d'aide

(Voir la liste exploitable détaillée à la **section 7.5**.)

| Catégorie | Ressource | Numéro |
|---|---|---|
| Urgence vitale | 911 | 911 |
| Santé / psycho-social 24/7 | Info-Santé / Info-Social | 811 |
| Suicide | Ligne québécoise / suicide.ca | 1 866 APPELLE / 535353 |
| Jeunes | Tel-jeunes / Jeunesse j'écoute | 1 800 263-2266 / 1 800 668-6868 |
| Enfance | DPJ | 1 800 463-9009 |
| Violence conjugale | SOS Violence Conjugale | 1 800 363-9010 |
| Aînés maltraités | Ligne Aide Abus Aînés | 1 888 489-2287 |
| Premières Nations / Inuits | Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être | 1 855 242-3310 |
| Substances | Drogue: aide et référence | 1 800 265-2626 |
| Référence services communautaires | 211 | 211 |

# 10. Recommandations stratégiques pour MESANGE

## 10.1 Positionnement légal sécuritaire

**À adopter** :

- Définition de MESANGE comme une **« plateforme d'écoute et de mieux-être préventif »**, **non médicale**, **non thérapeutique**.
- **Vocabulaire** : « accompagnement », « écoute », « personne accompagnée », « pratique de soin de soi », « ressource ».
- **Ne jamais** employer : thérapie, thérapeute, psychothérapie, traitement, diagnostic, patient, clinique, guérison.
- **Ne jamais** promettre un effet thérapeutique sur un trouble mental, une douleur chronique, une maladie spécifique.
- **Audit linguistique** trimestriel des contenus et messages générés par l'IA.

**À mettre en œuvre** :

1. Conditions d'utilisation explicitant que MESANGE n'est pas un service de santé.
2. **Avertissement systématique** au moment d'inscription : *« MESANGE n'offre pas de soins médicaux ni de psychothérapie. En cas de souffrance psychologique importante, d'idées suicidaires, ou de symptômes physiques préoccupants, contactez 911, 811 ou 1 866 APPELLE. »*
3. Architecture qui rend l'**orientation vers la ressource adéquate aussi visible et facile que la fonction de base**.

## 10.2 Modèle de protocole de redirection à intégrer dans la plateforme

```
ÉTAPES TECHNIQUES SUGGÉRÉES
──────────────────────────────────────────────

1. À chaque session : mini-écran de sécurité
   → « Es-tu en sécurité physique aujourd'hui ? »
   → 3 boutons : Oui / Non / Je ne sais pas

2. Détection passive (NLP) de drapeaux rouges
   dans les échanges :
   - mots-clés suicide / mort / plan / fin
   - mots-clés psychose / hallucinations / paranoïa
   - mots-clés violence / abus / coups
   - mots-clés douleur thoracique / AVC / urgence physique
   → Déclenche un overlay « Ressources immédiates »
     avec 911 / 811 / 1 866 APPELLE en un clic
     (cliquer = ouvre l'appel téléphonique)

3. Auto-évaluation hebdomadaire optionnelle
   PHQ-9 / GAD-7 + question subjective
   → Score ≥ seuil = orientation suggérée vers
     ressource professionnelle locale (annuaire)

4. Annuaire de ressources
   - GMF / GAP par région
   - Psychologues OPQ (recherche par tarif/région)
   - Organismes communautaires (ACSM, Revivre, etc.)
   - Lignes d'aide spécialisées
   - Médecines complémentaires réglementées
     (acupuncture, chiropratique)

5. Module « 4 piliers du mode de vie » (légitime,
   non médical) : sommeil, mouvement, lien social,
   silence/contemplation
```

### 10.3 Modèle de consentement éclairé et de limites de service

À présenter au moment de l'inscription, en français accessible :

> ***Ce que MESANGE est*** *— Une plateforme d'écoute empathique et de pratiques de mieux-être préventif. Nous t'accompagnons dans la prise de soin de toi : sommeil, gestion du stress, lien social, contemplation, silence.*
>
> ***Ce que MESANGE n'est pas*** *— MESANGE n'est ni un service médical, ni une psychothérapie, ni un substitut à un professionnel de la santé. Nous ne posons pas de diagnostic. Nous ne traitons pas les troubles mentaux ni les maladies physiques.*
>
> ***Quand contacter d'autres ressources*** *— • Si tu penses au suicide :* ***1 866 APPELLE (1 866 277-3553)*** *ou suicide.ca • Si tu vis une crise immédiate ou un danger :* ***911*** *• Pour un problème de santé physique ou mentale :* ***811*** *(24/7) ou ton médecin de famille • Pour de la psychothérapie, consulte le* ***registre des psychologues du Québec*** *(ordrepsy.qc.ca)*
>
> ***Confidentialité*** *— Tes échanges sont protégés. Voir notre Politique de confidentialité.* ***Mes données*** *— Tu peux les exporter ou les supprimer à tout moment.* ***Limites de l'IA*** *— MESANGE utilise des modèles d'intelligence artificielle qui peuvent se tromper ou ne pas comprendre une situation. Toute information à enjeu de santé doit être vérifiée auprès d'un professionnel.*

### 10.4 Pistes de partenariats

- **Ordres professionnels** : OPQ (psychologues), CMQ (médecins), OAQ (acupuncteurs), OCQ (chiropraticiens), Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ). Établir des **canaux de référence** sécurisants (OPQ, CMQ).
- **OBNL santé mentale** : ACSM (Association canadienne pour la santé mentale), Revivre, Relief, AQPS (Association québécoise de prévention du suicide) (CAP santé mentale).
- **GMF et CIUSSS** : projets pilotes de **prescription sociale** liés à un GMF (Clic Social).
- **Premières Nations** : démarche de consultation préalable avec **CSSSPNQL** et autorités locales avant tout déploiement vers ces communautés (CSSSPNQL).
- **Universités** : laboratoires de recherche en sciences contemplatives (Université de Montréal, McGill, Concordia), pour partenariats de validation et publications.

### 10.5 Veille réglementaire à mettre en place

Mettre en place une **veille trimestrielle** sur :

- Modifications du Code des professions (notamment art. 187.1 et 188).
- Évolutions de la **Loi 21** et des avis de l'**Office des professions**.
- **Loi P-38** (garde en établissement et danger pour autrui).
- Décisions de l'**OPQ** sur les zones grises (coaching, hypnose, accompagnement).
- **Santé Canada** sur les produits de santé naturels et l'IA en santé (cadre IA/SaMD).
- **Loi 25** (protection des renseignements personnels au Québec) — incontournable pour une plateforme numérique.
- **Lignes directrices de l'INESSS** sur les outils numériques de santé.

Sources de veille recommandées : Office des professions du Québec, OPQ, CMQ, INESSS, Commissaire à la santé et au bien-être, Publications du Québec.

# 11. Annexes

## 11.1 Glossaire

- **Acte réservé** : activité que seuls les membres d'un ordre professionnel peuvent poser. Article du Code des professions et lois constituantes des ordres.
- **Champ d'exercice** : description générale d'une profession ; il peut être exclusif ou partagé.
- **CIM-10 / CIM-11** : Classification internationale des maladies (OMS). CIM-11 en vigueur depuis 2022.
- **CISSS / CIUSSS** : Centre intégré (universitaire) de santé et de services sociaux. Établissements territoriaux issus de la réforme 2015.
- **CLSC** : Centre local de services communautaires (1ère ligne).
- **CSSSPNQL** : Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.
- **DSM-5-TR** : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5e édition révisée (APA, 2022).
- **EQSP** : Enquête québécoise sur la santé de la population (ISQ).
- **ESCC** : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (Statistique Canada).
- **GAMF** : Guichet d'accès à un médecin de famille.
- **GAP** : Guichet d'accès à la première ligne.
- **GMF** : Groupe de médecine de famille.
- **ICIS / CIHI** : Institut canadien d'information sur la santé.
- **INSPQ** : Institut national de santé publique du Québec.
- **INESSS** : Institut national d'excellence en santé et services sociaux.
- **ISQ** : Institut de la statistique du Québec.
- **Loi 21 (PL 21)** : Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (en vigueur en 2012).
- **Loi P-38** : Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
- **Loi 25** : Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Québec).
- **MCA / MAC** : Médecines complémentaires et alternatives.
- **MBSR / MBCT** : Mindfulness-Based Stress Reduction / Mindfulness-Based Cognitive Therapy.
- **MSSS** : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
- **OAQ / OCQ** : Ordre des acupuncteurs du Québec / Ordre des chiropraticiens du Québec.
- **OPQ** (les deux sens) : Ordre des psychologues du Québec **ou** Office des professions du Québec — selon contexte. Dans ce rapport, l'**OPQ** désigne par défaut l'**Ordre des psychologues** sauf mention explicite.
- **PCAP** : Propriété, contrôle, accès, possession (gouvernance des données autochtones).
- **Principe de Joyce** : principe d'accès équitable aux services de santé pour les Autochtones, reconnaissance des savoirs traditionnels.
- **Psychothérapie** : traitement psychologique d'un trouble mental ou d'une souffrance psychologique, acte réservé au sens de l'art. 187.1 du Code des professions.
- **RAMQ** : Régie de l'assurance maladie du Québec.

- **Sécurisation culturelle** : approche garantissant que les services soient sûrs aux yeux des personnes autochtones, au-delà de la « compétence culturelle ».

## 11.2 Liste exhaustive des sources avec URLs

**Sources institutionnelles québécoises et canadiennes**

- Régie de l'assurance maladie du Québec — RAMQ
- Ministère de la Santé et des Services sociaux — MSSS
- Gouvernement du Québec — Données sur l'accès aux services médicaux de première ligne
- Gouvernement du Québec — Suivi de la Commission Viens
- Gouvernement du Québec — Consentir à des soins de santé en cas d'inaptitude
- Institut canadien d'information sur la santé (ICIS / CIHI) — Tendances des dépenses 2024
- ICIS — National Health Expenditure Trends 2024 (data tables)
- Institut de la statistique du Québec — Habitudes de vie et comportements
- ISQ — Troubles d'anxiété
- INSPQ — Données et mesures en santé mentale
- INSPQ — Déterminants de la santé
- INSPQ — Isolement et participation sociale des aînés
- INSPQ — Boîte à outils sur les instruments standardisés (consommation d'alcool)
- INESSS — Site officiel
- Commissaire à la santé et au bien-être — Publications
- Commissaire à la santé et au bien-être — Rapport annuel de gestion 2023-2024
- Statistique Canada
- Statistique Canada — CPE 2021 Médecines alternatives et douces

**Cadre légal et professionnel**

- Code des professions — Publications du Québec
- Office des professions du Québec — Avis sur l'opportunité de constituer un ordre professionnel des ostéopathes (2022)
- Office des professions — Guide explicatif Loi 21
- Ordre des psychologues du Québec — Qui pratique la psychothérapie?
- Ordre des psychologues du Québec — Obtenir un permis
- Ordre des chimistes du Québec — Exercice illégal et usurpation de titre
- Ordre des acupuncteurs du Québec — OAQ
- Association des chiropraticiens du Québec — ACQ
- Collège des médecins du Québec — CMQ

**MCA et associations**

- Association des naturopathes agréés du Québec — ANAQ
- Association des Naturopathes Professionnels du Québec — ANPQ
- UETMIS-CHUS — Revue systématique des médecines complémentaires (2012)

**Premières Nations et autochtones**

- Principe de Joyce
- CSSSPNQL — Enquête régionale sur la santé
- Programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et les Inuit au Québec — PFMPNIQ
- CATIE — Traditions de guérison des Autochtones nord-américains
- Protecteur du citoyen — Suivi Commission Viens

**Données probantes santé mentale et contemplative**

- PMC — Effectiveness of MBSR (revue PRISMA 2020)
- BMJ Open — Systematic review of yoga therapy for mood disorders (2024)
- PubMed — Hofmann et al., effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression (2010)
- Annie Wright — Spiritual Bypassing
- OMS — CIM-11

**Outils de dépistage**

- PHQ Screeners — PHQ-9, GAD-7
- Boussole / eSantéMentale — GAD-7 français Canada
- C-SSRS Columbia Suicide Severity Rating Scale
- CRAFFT.org

**Ressources d'urgence et lignes d'aide**

- CAP santé mentale — Lignes d'écoute 24/7
- Centre de prévention du suicide de Montréal
- Suicide.ca
- Tel-jeunes
- Jeunesse, j'écoute
- Écoute-Entraide
- CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal — Info-Santé/Info-Social 811
- CIUSSS de la Capitale-Nationale — Urgences psychiatriques

**Cadres mode de vie et prescription sociale**

- American College of Lifestyle Medicine — ACLM
- Prescription sociale Québec / Clic Social
- OMS — Activité physique

**Autres**

- Fraser Institute — Waiting Your Turn 2024
- Clinique Hormona — Coaching vs psychothérapie
- CIUSSS Est-de-l'Île-de-Montréal — Personnes sans médecin de famille recherchées
- Santé Canada — Produits de santé naturels

## Note méthodologique et limites

- Toutes les données chiffrées proviennent de sources publiques et institutionnelles ; les variations entre années d'enquête et entre méthodologies (ex. EQSP vs ESCC) expliquent certains écarts.
- Le présent rapport est un **outil d'orientation stratégique** pour MESANGE ; il **ne constitue pas un avis juridique formel**. Avant tout déploiement public, MESANGE devrait obtenir un avis d'un avocat québécois spécialisé en droit de la santé / droit professionnel, et un avis d'un cabinet en conformité réglementaire pour la dimension protection des renseignements personnels (Loi 25) et pour l'usage de l'IA en contexte de santé/mieux-être.
- Le statut réglementaire de plusieurs pratiques (ostéopathie notamment) est **en évolution** ; une veille trimestrielle est essentielle.
- Les données sur les MCA s'appuient en partie sur l'étude Fraser de 2006 (Esmail) car aucune enquête nationale comparable plus récente n'a été identifiée ; elles restent les plus citées en littérature québécoise.
- La position scientifique sur les approches énergétiques, la médecine traditionnelle non occidentale et les pratiques émergentes évolue : MESANGE doit maintenir une **posture épistémique humble** — rapporter les données existantes, ne pas surpromettre, ne pas dénigrer.

*Rapport préparé pour David Phaneuf, fondateur de MESANGE. Utilisation interne. Toute citation publique des recommandations stratégiques (section 10) devrait être validée par conseil juridique québécois préalable.*